NAJDETE HO A VÍTE, CO DĚLAT™

Průvodce protahováním podle tělesných oblastí

Protažení všech 60 svalů na jednom místě, podle tělesných oblastí, ve stejném pořadí jako atlas a protokoly.

Atlas spoušťových bodů · Vzdělávací materiál pro zdravotnické odborníky a studenty. Nenahrazuje lékařskou diagnózu.

Obsah

1 · Jak protahovat

2 · Hlava, obličej a krk

3 · Rameno, paže a ruka

4 · Záda a trup

5 · Pánev a kyčel

6 · Stehno, bérec a chodidlo

Další krok

ČÁST 1

Jak protahovat

Tři pravidla pro každé protažení.

Pravidla

- [ ] Do protažení jděte pomalu, při výdechu, bez hmitání.
- [ ] Má to být mírný tah, nikdy bolest: pokud to bolí, povolte.
- [ ] Vydržte 20–30 sekund, 3 opakování; po ošetření vždy protáhněte.

ČÁST 2

Hlava, obličej a krk

Pro terapeuta i pro pacienta.

Trapezius – horní vlákna

Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírnou flexí; vsedě se pacient drží rukou na stejné straně za spodek židle.

3 × 20–30 s

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hlava ukloněná na opačnou stranu, poté se brada pomalu otáčí k ošetřované straně; mírný záklon jen tehdy, pokud nevyvolává závrať.

3 × 20–30 s

Masseter (žvýkací sval)

Pomalé otevírání úst se špičkou jazyka na patře; dva prsty terapeuta jemně pomáhají čelisti dolů.

3 × 20–30 s

Temporalis (spánkový sval)

Pomalé otevírání úst, zatímco prsty terapeuta hladí na spánku směrem nahoru.

3 × 20–30 s

Pterygoideus lateralis

Pomalá retrakce dolní čelisti (pacient mírně stáhne bradu dozadu), poté pomalé zavření úst.

3 × 20–30 s

Pterygoideus medialis

Pomalé otevírání úst s čelistí mírně posunutou na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Splenius capitis

Hlava v předklonu a otočená na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Splenius cervicis

Hlava v předklonu a v úklonu s rotací na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Subokcipitální svaly

Zasunutí brady (hlava klouže rovně dozadu), poté mírné kývnutí dopředu.

3 × 20–30 s

Semispinalis capitis

Hlava v předklonu s mírnou rotací do strany.

3 × 20–30 s

Levator scapulae (zdvihač lopatky)

Hlava v předklonu a otočená na opačnou stranu (nosem k podpaží), ruka ošetřované strany za zátylkem.

3 × 20–30 s

Skalenové svaly

Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírným záklonem; terapeut fixuje klíční kost ošetřované strany směrem dolů.

3 × 20–30 s

ČÁST 3

Rameno, paže a ruka

Pro terapeuta i pro pacienta.

Infraspinatus

Paže ošetřované strany zkřížená přes hrudník, druhou rukou přitahujte loket k hrudníku; nebo ruka za zády.

3 × 20–30 s

Supraspinatus

Ruka ošetřované strany za zády, druhá ruka jemně táhne zápěstí na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Teres minor

Paže zkřížená přes hrudník, loket přitažený k hrudníku.

3 × 20–30 s

Subscapularis

Paže v zevní rotaci, loket v 90°, ruku jemně nechat jít dozadu (u zárubně dveří).

3 × 20–30 s

Deltoideus

Přední vlákna: paže dozadu; zadní vlákna: paže zkřížená přes hrudník.

3 × 20–30 s

Pectoralis major

Protažení ve dveřích: předloktí na zárubni, loket ve výši ramene, tělo pomalu vykročí dopředu.

3 × 20–30 s

Pectoralis minor

Ramena dozadu a dolů; u zárubně loket nad výší ramene.

3 × 20–30 s

Rhomboideus

Paže zkřížené vpředu (objetí sebe sama), záda mírně vyhrbená.

3 × 20–30 s

Serratus anterior

Paže dozadu a lopatka přitažená k páteři; při hlubokém nádechu.

3 × 20–30 s

Latissimus dorsi

Paže nad hlavou, trup v úklonu na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Biceps brachii

Loket natažený, předloktí v pronaci, paže dozadu.

3 × 20–30 s

Triceps brachii

Paže nad hlavou, loket plně pokrčený, druhá ruka ho jemně tlačí dozadu.

3 × 20–30 s

Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Loket natažený, zápěstí a prsty ve flexi, druhá ruka jemně táhne dolů.

3 × 20–30 s

Flexory předloktí

Loket natažený, dlaň nahoru, prsty tažené dozadu.

3 × 20–30 s

ČÁST 4

Záda a trup

Pro terapeuta i pro pacienta.

Trapezius – střední vlákna

Paže zkřížené vpředu, záda vyhrbená.

3 × 20–30 s

Trapezius – dolní vlákna

Paže dopředu a nahoru, záda vyhrbená.

3 × 20–30 s

Serratus posterior superior

Paže zkřížená vpředu, záda vyhrbená.

3 × 20–30 s

Iliocostalis thoracis

Vsedě předklon, trup mírně otočený na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Iliocostalis lumborum

Vleže na zádech kolena přitažená k hrudníku.

3 × 20–30 s

Longissimus thoracis

Vsedě předklon, nebo vleže na zádech kolena k hrudníku.

3 × 20–30 s

Multifidus

Vleže na zádech kolena k hrudníku s mírnou rotací do strany.

3 × 20–30 s

Quadratus lumborum

Ve stoje nebo vleže na boku úklon, horní paže nad hlavou.

3 × 20–30 s

Rectus abdominis

Vleže na zádech, polštář pod bedry, paže nad hlavou.

3 × 20–30 s

Obliquus externus abdominis

Vleže na zádech kolena spuštěná na opačnou stranu, ramena na podložce.

3 × 20–30 s

ČÁST 5

Pánev a kyčel

Pro terapeuta i pro pacienta.

Gluteus maximus

Vleže na zádech koleno přitažené k opačnému rameni.

3 × 20–30 s

Gluteus medius

Vleže na boku horní noha visí za tělem přes okraj lehátka; nebo ve stoje se zkříženýma nohama úklon do strany.

3 × 20–30 s

Gluteus minimus

Vleže na zádech noha zkřížená na opačnou stranu.

3 × 20–30 s

Piriformis

Vleže na zádech kotník ošetřované nohy na druhém koleni, druhé stehno přitažené k hrudníku (protažení do čtyřky).

3 × 20–30 s

Iliopsoas

Poloha ve výpadu: zadní koleno na zemi, pánev tlačená dopředu.

3 × 20–30 s

Tensor fasciae latae (TFL)

Vleže na boku horní noha natažená, spuštěná dozadu a dolů.

3 × 20–30 s

Adductor longus

Vsedě chodidla k sobě (motýlek), kolena spuštěná dolů.

3 × 20–30 s

Adductor magnus

Vsedě v roznožení předklon.

3 × 20–30 s

Pectineus

Noha v abdukci a natažená, mírně dozadu.

3 × 20–30 s

Sartorius

Kyčel v extenzi, mírně ve vnitřní rotaci (poloha ve výpadu).

3 × 20–30 s

ČÁST 6

Stehno, bérec a chodidlo

Pro terapeuta i pro pacienta.

Rectus femoris

Vleže na břiše nebo ve stoje pata přitažená k hýždi, kyčel v extenzi.

3 × 20–30 s

Vastus medialis

Koleno plně pokrčené (pata k hýždi).

3 × 20–30 s

Vastus lateralis

Koleno plně pokrčené, noha mírně ve vnitřní rotaci.

3 × 20–30 s

Biceps femoris

Vleže na zádech zvedání natažené nohy, kotník přitažený.

3 × 20–30 s

Semitendinosus / semimembranosus

Vleže na zádech zvedání natažené nohy, mírně do strany.

3 × 20–30 s

Gastrocnemius

Ve stoje u zdi, zadní noha natažená, pata na zemi.

3 × 20–30 s

Soleus

Ve stoje u zdi, zadní koleno mírně pokrčené, pata na zemi.

3 × 20–30 s

Tibialis anterior

Kotník a prsty v plantární flexi (vsedě nárt podvrácený pod sebe).

3 × 20–30 s

Peroneus (fibularis) longus

Noha vytočená dovnitř a v plantární flexi.

3 × 20–30 s

Tibialis posterior

Noha vytočená zevně a v dorzální flexi.

3 × 20–30 s

Extensor digitorum longus

Prsty a kotník v plantární flexi.

3 × 20–30 s

Flexor digitorum brevis

Prsty nohy přitažené nahoru, kotník v dorzální flexi.

3 × 20–30 s

Abductor hallucis

Palec nohy tažený dovnitř (k ostatním prstům), kotník v dorzální flexi.

3 × 20–30 s

Quadratus plantae

Prsty a kotník v dorzální flexi.

3 × 20–30 s

Další krok

Dnes: vyzkoušejte si protažení krku a ramen na sobě, abyste je mohli pacientovi přesně vysvětlit.